

令和7年(行ウ)第20号、同第32号 地位確認等請求事件

原告 株式会社長澤薬品ほか2名

被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣)

準備書面 (4)

令和8年3月19日

東京地方裁判所民事第38部B1係 御中

被告指定代理人	志	水	崇	通
	小	西	俊	輔
	渡	邊	正	幸
	後	藤	優	太
	大	原		拓
	松	岡	克	朗
	山	下	雄	大
	中	村	早	希
	末	永	朝	美
	内	田	成	美

小	野	雅	世
西	村	美	鈴
山	本		剛
岩	瀬		怜
阿	部		讓
篠	原	太	一
澤	本	美	穂
平	田	優	佳
数	井	駿	兵

被告は、本書面において、令和8年2月3日付け原告ら第4準備書面(以下「原告ら第4準備書面」という。)に対し、必要な範囲で反論する。

なお、略語等は、本書面で新たに定めるもののほか、従前の例による。

第1 「医業」に係る原告らの主張は理由がないこと

1 原告らの主張

被告がこれまで繰り返し述べているとおり、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を処方する行為は、当該医薬品が要指導医薬品や一般用医薬品と同一の有効成分を持つ医療用医薬品の場合であろうとも、実質的に「医行為」に該当するものであり、薬剤師がこれを業として行うこと(「医業」)は、明らかに薬剤師の職能の範囲外であって、医師による医業独占を定めた医師法17条に反する(被告準備書面(2)第2の2(5)イ・33ないし36ページなど)。

これに対し、原告らは、①「処方箋以外(マ)の医療用医薬品の販売が「医業」に該当するのであれば、なぜ被告は今まで、医療用医薬品全てを「厚生労働大臣の指定」により処方箋医薬品にしなかったのか」について合理的な理由を説明できていないとか、②令和8年6月から実施されることが決定された、医療費の削減のための施策として、「医療医薬品(マ)の処方数を薬剤師の判断のみで削減できるものとし、医師への確認を省略する制度」は医師法17条に抵触しており、上述した被告の主張と矛盾するなどと主張する(原告ら第4準備書面第1の2(3)・4及び5ページ)。

2 被告の反論

(1) 原告らは、処方箋医薬品の分類を正解せず、薬機法49条1項の趣旨を見誤るものであること(前記1①に対する反論)

ア 被告がこれまで繰り返し述べているとおり、処方箋医薬品は、「覚醒剤」や「麻薬製剤」、「放射性医薬品」のように、その成分等により保健衛生上のリスクが生じ得るものとして指定され、製剤としての取扱い自体に關す

るリスクが高いか否かを基準に指定されている医薬品群である。薬機法 49 条 1 項は、このような処方箋医薬品の製剤としての取扱い自体に係るリスクの高さに鑑みて、これが「不用意に一般の生活者の手に渡り不適正に使用されることのないよう」にするために設けられた規定であり(乙 10 の 2・480 ページ)、その違反に対して特に罰則を科す(同法 84 条 17 号)という厳格な運用を求めることにより、当該医薬品の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止(同法 1 条参照)を図ったものといえる(以上につき、被告準備書面(1)第 1 の 2 (3)・8 及び 9 ページ、被告の令和 7 年 12 月 16 日付け準備書面(3)(以下「**被告準備書面(3)**」という。)第 2 の 2 (1)イ(イ)・18 及び 19 ページなど)。

このように、処方箋医薬品は、その製剤としての取扱い自体に関するリスクの高さゆえに、他の医療用医薬品とは異なる規制が設けられた医薬品群であるところ、原告らの前記 1 ①の主張は、このような処方箋医薬品の分類を正解せず、薬機法 49 条 1 項の趣旨を見誤るものというほかない。

イ この点を更にふえんすると、その効能及び効果において人体に対する作用が著しい、保健衛生上のリスクが高い医薬品である薬局医薬品から薬局製造販売医薬品を除いた医薬品(＝医療用医薬品)は、原則として、医師等の医療の専門家によって使用の判断がされる医薬品群であり、これを処方する行為は「医行為」(絶対的医行為)に該当するから、薬剤師がこれを業として行うこと(「医業」)は、薬機法の規定を待つまでもなく許されない(被告準備書面(2)第 2 の 2 (5)イ・33 ないし 36 ページなど)。また、上述した点に照らせば、業として行う場合でなくとも、薬剤師において、患者の状態に照らして特定の疾患等に該当すると判断し、それに対応する効能・効果を有する医療用医薬品及びその用法・用量の選択を行うことは、その職能の範囲外であり、薬機法の趣旨に反する(被告準備書面(1)第 1 の 4 (4)・28 ないし 32 ページ、被告準備書面(3)第 2 の 2 (1)イ(ア)・17

及び18ページなど)。

しかるところ、薬機法49条1項は、上記の点を前提として、医療用医薬品のうち、その成分等から製剤としての取扱い自体に関するリスクが高い医薬品群について、これが不用意に一般の生活者の手に渡り不適正に使用されることのないようにするため、特に厳格な規制を設けたものであるから、その対象が全ての医療用医薬品とされていないのは、むしろ当然というべきである。

ウ したがって、原告らの前記1①の主張は理由がない。

(2) 原告らが指摘する制度は、「残薬対策の推進の一環」として、保険医療機関の指示に基づいてなされるものであり、医療用医薬品の処方数を薬剤師の判断のみで削減することを認めるものではないこと(前記1②に対する反論)

原告らは、甲第39号証を挙げて前記1②のとおり主張するが、以下のとおり、被告において、「医療医薬品(マ)の処方数を薬剤師の判断のみで削減できるものとし、医師への確認を省略する制度」の導入を議論した事実はなく、原告らの前記1②の主張は、明らかに前提を誤るものである。

ア 令和8年2月2日付けの報道記事である甲第39号証は、その作成時期に照らし、同年1月28日に開催された第645回中央社会保険医療協議会総会(以下「**本総会**」という。)で取り扱われた議論に関する記事であることがうかがわれる。もっとも、本総会では、「残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し」のテーマについて、「処方箋様式の備考欄のうち、**保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄**について、「**調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供する**」ことも**保険医療機関が指示できる**よう見直す」(乙34の1及び2。下線部分は被告による(以下同じ。))ことが議論されたにすぎず、「医療医薬品(マ)の処方数を薬剤師の判断のみで削減できるものとし、医師への確認を省略する制度」の導入を議論した事実はない。

すなわち、現行の処方箋様式(別紙1)においては、「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」として、①「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」及び②「保険医療機関へ情報提供」のチェック欄が設けられ、当該欄にチェックがある場合は薬局において患者の残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合には、チェックされた内容(保険医療機関の指示)に応じた対応を行うこととされている。これに対し、本総会における議論は、専ら「残薬対策の推進」のために、「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」として、上記②に代えて新たに②´「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」のチェック欄を設けるというものであり、要するに、当該残薬分を減じて調剤することについて、処方箋の処方量の変更に関する都度の疑義照会を調剤の前に行わずとも、医療機関への情報提供を事後的に行うことでよい旨を、予め「保険医療機関が指示できるように、処方箋様式を見直す」ものである(別紙2)。そのため、見直しが行われた処方箋様式における保険医療機関の指示に基づき薬剤師が行う調剤行為については、薬剤師法23条2項に規定する「処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合」に該当するものであり、現行の薬剤師の調剤業務の範囲を何ら逸脱、変更するものではない(したがって、医師法17条に抵触するものでもない。)。

なお、上記議論の内容は、令和8年度診療報酬改定に係る中央社会保険医療協議会からの答申に盛り込まれていることから、かかる内容の制度が令和8年6月より開始されることになる。

イ 以上のとおり、被告は、残薬対策の推進の一環として、処方箋様式の備考欄において予め「保険医療機関が指示」することで、調剤時に残薬を把握した薬剤師が処方量を減じて調剤することができる制度見直しについて議論したものである。当該議論の内容をもって、「医療医薬品(マ)の処方数を薬剤師の判断のみで削減できる」という制度見直しがされるという原告

らの指摘は、全くの事実誤認であるといわざるを得ない。

したがって、かかる誤った前提に立ち、医師法 17 条に係る被告の主張を論難する原告らの前記 1 ②の主張は、明らかに理由がない。

第 2 薬機法 49 条 1 項の解釈に係る原告らの主張は理由がないこと

1 原告らの主張

(1) 原告らは、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して正当な理由なく医薬品を販売してはならない旨を定めた規定は、処方箋医薬品を対象とする薬機法 49 条 1 項のみであり、それ以外の医療用医薬品については、このような規定がない以上、その販売について処方箋の交付が義務付けられていないと解することが、薬機法の解釈の「当たり前の帰結」である旨主張する(原告ら第 4 準備書面第 1 の 1・1 及び 2 ページ)。

(2) また、原告らは、前記(1)の点に関連し、次のとおり主張する。

ア 平成 14 年法律第 96 号による薬事法等の改正(以下「平成 14 年改正」という。)で設けられた「処方箋医薬品」の分類は、日本医師会による政治的圧力を受けて零売薬局を規制する目的で生み出されたものであって、「特定の零売薬局を標的とした医師会への政治的配慮であった」(原告ら第 4 準備書面第 2 の 1・5 ないし 7 ページ)。

イ 被告は、平成 14 年改正において、「当初すべての医療用医薬品を「処方箋医薬品」に指定し、零売を根絶しよう」と目論んだが、それにもかかわらず、「零売の是非はあいまいなまま、品目が見直されただけという結果に終わった」。このことは、「被告が、医療用医薬品に関して、「医師の診断なしに販売することに、一律に保健衛生上の危害がある」という主張を、法学的・医学的に証明できなかったことを意味する」。「医療用医薬品が本質的に危険なものであれば、当時、全ての医療用医薬品が処方箋医薬品に指定されていたはずである」(原告ら第 4 準備書面第 2 の 2・7 ページ)。

2 被告の反論

(1) この点、被告がこれまで繰り返し述べ、前記第1の2(1)で改めてふえんして説明したとおり、薬機法49条1項は、薬剤師において、患者の状態に照らして特定の疾患等に該当すると判断し、それに対応する効能・効果を有する医療用医薬品及びその用法・用量の選択を行うことが、その職能の範囲外であることを当然の前提とした上で、「覚醒剤」や「麻薬製剤」、「放射性医薬品」のように、その成分等から製剤としての取扱い自体に関するリスクが高い医薬品群が、不用意に一般の生活者の手に渡り不適正に使用されることのないようにするため、これらの医薬品群について特に厳格な規制を設け、安全性を確保しようとしたものである。

そのため、薬機法49条1項の規制対象が全ての医療用医薬品とされていないことは、これらの処方箋医薬品以外の医療用医薬品について制限なく販売できることを意味するものではない。原告らにおいて薬機法49条1項の「当たり前の帰結」とであると述べる法解釈(前記1(1))は、同条項の文理のみを硬直的に捉えるものというほかない。

したがって、これ以上、原告らの前記1の主張について反論する必要を認めないのであるが、その主張内容によれば、原告らが前提とする平成14年改正に係る事実認識(前記1(2))には明らかな誤りがあると認められるため、以下、念のため、この点に限って簡単に反論する。

(2) 原告らは、前記1(2)アのとおり、平成14年改正で「処方箋医薬品」の分類が設けられた経緯について、日本医師会による政治的圧力である旨を種々主張する。

しかしながら、その根拠として挙げられているのは、一雑誌記事(甲41)にすぎず、何らの裏付けも伴っていない。原告らが挙げる元厚生労働省職員等による座談会記事(甲43)を見ても、日本医師会側に要望の有無を尋ねた際に「新潟のドラッグストア対策を何とかしてくれという話が来た」などの

内容にとどまるものであって、原告らが主張するような政治的圧力の存在をうかがわせるものではない。もとより、被告として、法改正に向けて業界団体を含む関係者との意見交換を実施すること自体は極めて自然であり、実際、今般、「零売薬局」に関する法改正を検討した際にも、「医薬品の販売制度に関する検討会」を通じて、一般社団法人日本零売薬局協会を含む「零売薬局」を運営する事業者との意見交換を実施している(乙33の1)。そうであるにもかかわらず、原告らは、厚生労働省が特定の業界団体と意見交換を行ったという事実のみをもって、当該団体からの政治的圧力で処方箋医薬品の分類を設ける法改正が行われたという一方的な主張を展開しており、明らかに論理の飛躍がある。

したがって、原告らの前記1(2)アの主張は、事実認識を誤るものであって、明らかに理由がない。なお、念のため付言すると、平成14年改正における薬機法(当時の名称は薬事法。以下同じ。)49条1項の改正が、原告らの主張するような政治的圧力を契機としたものではなく、安全性を確保するためのものであることは、次のとおり、国会答弁(「第154回国会衆議院厚生労働委員会議録第27号」)でも明らかにされている。

○ 金田誠一委員

「薬事法の一部改正についてお尋ねをしたいと思います。(中略)第四十九条が改正されるわけでございます。(中略)報道によりますと、この改正の背景には、昨年十月に新潟にオープンしたある薬局が、要指示薬以外の医薬品、このグレーの部分でございますが、このグレーの部分を処方せんなしで販売を始めたのに対し、地元医師会が反対して、医薬品分類の見直しに発展したというふうに報道されておりますけれども、これに間違いございませんでしょうか。(以下、省略)」

○ 宮島彰政府参考人(厚生労働省医薬局長)

「今回の改正におきまして医薬品分類の見直しを行いましたのには、一つには医療用医薬品と申しますのは、基本的には医師等の処方によって適正に使用されることを前提として供給されている医薬品であるということでございます。それから、二つ目には、現実の実態といたしましても、医療用医薬品の大部分は医師等の処方せんによって使用されているということなどを踏まえまして、医薬品の適正使用の一層の徹底を図るという観点から、販売規制上の分類である要指示医薬品の範囲を拡大いたしまして、処方せん医薬品として今回指定することとしたものであります。いわゆる安全性確保のための必要な改正であるというふうに認識しておりまして、御指摘いただいた事例が改正の契機となったということではないということでございます。」

- (3) また、原告らは、前記 1 (2) イのとおり主張するが、そもそも平成 14 年改正において、被告が「零売を根絶しよう」と目論んだ」とする主張自体、根拠に基づかない独自の見解というほかない。

これまで被告が繰り返し述べているとおり、医療用医薬品の分類それ自体は、処方箋医薬品に指定されているか否かを問わず、その適切な使用を確保するために医師等の判断が介在することが前提となっている医薬品を指しており、「医師の診断なしに販売することに、一律に保健衛生上の危害がある」か否かという観点から分類されているものではない(被告準備書面(2)第 2 の 2 (2) イ(イ)・25 ページなど)。そして、処方箋医薬品以外の医療用医薬品は、処方箋医薬品と比較すれば、その成分等に関しては比較的风险が低いといえるのであるから、製剤としての取扱い自体に関するリスクが高い医薬品を特に処方箋医薬品として指定したからといって、それ以外の医療用医薬品について、保健衛生上のリスクが低いという結論が導かれないことは明らか

といえる。

したがって、原告らの前記 1(2)の主張は、事実認識を誤るものであって、明らかに理由がない。

なお、平成 14 年改正について念のため付言すると、同改正前の薬機法 49 条 1 項は、販売規制上の分類として「要指示医薬品」という分類を設け、医師等から処方箋の交付又は指示を受けた者に対して、要指示医薬品の販売等を行うことを禁止していたところ、前述した国会答弁のとおり、医療用医薬品は、基本的には医師等の処方によって適正に使用されることを前提として供給されている医薬品であり、その大部分は医師等の処方箋によって使用されているという実情が認められた。このことから、平成 14 年改正においては、注射剤や麻薬製剤等といった製剤としての取扱い自体に関するリスクが高い医薬品の適正使用を一層徹底するとともに、それまで許容されていた口頭指示等による明瞭でない販売等を改める目的で、「要指示医薬品」の呼称を「処方箋医薬品」と改め、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならないことを明記したものである（乙 11）。

以 上

処 方 箋															
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)															
公費負担者番号				保険者番号											
公費負担医療の受給者番号				被保険者資格に係る記号・番号				・ (枝番)							
患 者	氏 名		保険医療機関の所在地及び名称												
	生年月日		明大昭平令		年 月 日		男・女		電 話 番 号				保 険 医 氏 名		
	区 分		被保険者		被扶養者		都道府県番号		点数表番号		医療機関コード		⑩		
交付年月日				令和 年 月 日				処方箋の使用期間		令和 年 月 日				特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること。	
処 方	変更不可 (医療上必要)		患者希望		個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載すること。										
					リフィル可 ☐ (回)										
備 考	保険医署名				「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載した場合は、署名又は記名・押印すること。										
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。) ☐ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 ☐ 保険医療機関へ情報提供															
調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)															
□ 1回目調剤日 (年 月 日) □ 2回目調剤日 (年 月 日) □ 3回目調剤日 (年 月 日)															
次回調剤予定日 (年 月 日) 次回調剤予定日 (年 月 日)															
調剤済年月日				令和 年 月 日				公費負担者番号							
保険薬局の所在地及び名称 保険薬剤師氏名				⑩				公費負担医療の受給者番号							

備考 1. 「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
2. この用紙は、A列5番を標準とすること。
3. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とあるのは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとする。

処方箋 (この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)																
公費負担者番号								保険者番号								
公費負担医療の受給者番号								被保険者資格に係る記号・番号				・ (枝番)				
患者	氏名						保険医療機関の所在地及び名称									
	生年月日		明大昭平令		年 月 日		男・女		電話番号							
	区分		被保険者		被扶養者		保険医氏名 ㊞									
								都道府県番号				点数表番号		医療機関コード		
交付年月日				令和 年 月 日				処方箋の使用期間				令和 年 月 日				
				特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること。												
処方	変更不可 (医療上必要)		患者希望		個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載すること。											
					リフィル可 ☐ (回) ※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋											
備考	保険医署名				「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載した場合は、署名又は記名・押印すること。											
	保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。) ☐ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 ☐ 調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供															
調剤実施回数（調剤回数に応じて、 ☐ に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。） ☐ 1回目調剤日（ 年 月 日） ☐ 2回目調剤日（ 年 月 日） ☐ 3回目調剤日（ 年 月 日） 次回調剤予定日（ 年 月 日） 次回調剤予定日（ 年 月 日）																
調剤済年月日				令和 年 月 日				公費負担者番号								
保険薬局の所在地及び名称 保険薬剤師氏名				㊞				公費負担医療の受給者番号								
備考 1. 「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。 2. この用紙は、A列5番を標準とすること。 3. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51年厚生省令第36号）第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とあるのは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとする。																